

Czym jest STPP

Krótkoterminowa terapia psychodynamiczna to nie „skrótowa psychoanaliza” — to osobna metoda: jasny cel, aktywny terapeuta, fokus na emocjach blokowanych przez obrony.

CZAS: 15 min Pacjent po terapii poznawczej; pierwsza sesja podejścia dynamicznego

ŹRÓDŁO: Shedler (2010); Malan; Davanloo

JAK UŻYWAĆ

Wprowadzasz pacjentowi STPP (ang. *Short-Term Psychodynamic Psychotherapy*) jako terapię dynamiczną z jasnym celem i ramą czasową 16–30 sesji. Wyjaśniasz, że pracujecie z tym, co poniżej świadomości — z **uczuciami blokowanymi przez obrony** i z tym, jak te blokady wpływają na życie. Odróżniasz STPP od klasycznej psychoanalizy (fokus, krótkość, aktywny terapeuta) i od terapii poznawczej (emocje i wzorce relacyjne, nie tylko myśli).

DLACZEGO TO DZIAŁA

STPP to **rodzina podejść** o ograniczonej ramie czasowej i skoncentrowanym fokusie. Wszystkie modele łączy praca z nieświadomym konfliktem (impuls ↔ lęk ↔ obrona), fokus na emocjach, użycie przeniesienia jako narzędzia wglądu oraz rama czasowa jako dźwignia motywacji. To metoda oparta na dowodach: meta-analizy z randomizacją (ang. *RCT*) pokazują skuteczność porównywalną z terapią poznawczą (Abbass i in., 2014).

01



Sześć cech STPP

Przedstaw pacjentowi, czym ta terapia różni się od stereotypu „leżenia na kozetce”. Wyjaśnij każdą cechę krótko i konkretnie.

- ① **Krótkoterminowa** — zwykle 16–30 sesji
- ③ **Fokus** — jeden, dwa kluczowe wzorce
- ⑤ **Aktywacja afektu** — doświadczenie uczuć

- ② **Aktywna** — terapeuta interweniuje, nie milczy
- ④ **Konfrontacja obron** — łagodne wskazywanie
- ⑥ **Oparta na dowodach** — skuteczna jak terapia poznawcza

02



Czym różni się od innych podejść

Pacjent po terapii poznawczej może zakładać, że dynamika to „kopanie w dzieciństwie bez celu”. Prostuj: STPP ma cele i strukturę, tylko pracuje innymi narzędziami. Celem jest zmiana **wzorca**, nie tylko objawu.

NOTATKA: JAK WYJAŚNIĆ RÓŻNICĘ TEMU PACJENTOWI

03 Rola ramy czasowej

Ograniczenie czasu nie jest kompromisem — jest narzędziem. „Znajomość końca daje strukturę. Nie pracujemy w nieskończoność — mamy konkretny cel.” Separacja od terapeuty pod koniec staje się sama w sobie obszarem terapeutycznym.

USTALONA LICZBA SESJI

— 16 / 20 / 24 / 30

04 Zaproś pytania pacjenta

Odpowiedz na wątpliwości. Typowa obawa: „czy 20 sesji wystarczy?” — wyjaśnij, że dowody są. Zapisz pytania, które pacjent zadał, i jak na nie odpowiedziałeś/-aś.

PYTANIA PACJENTA I MOJE ODPOWIEDZI

Klucz: STPP nie jest skróconą psychoanalizą ani konkurencją dla terapii poznawczej — to osobna metoda z własnym modelem zmiany. Pracuje z niewyrażonymi emocjami i wzorcami relacyjnymi, ma jasny cel, strukturę i ramę czasową. Główne modele: ISTDP (Davanloo), DIT (Lemma), TLDP (Strupp), APT (McCullough), AEDP (Fosha).